

# DANH SÁCH THÀNH VIÊN LỚP DA23YKA

1. Nguyễn Tuấn Duy
2. Nguyễn Ngô Minh Thơ
3. Trần Thị Huyền Trang
4. Lê Nguyễn Ngọc Vân An
5. Phan Nhật Anh
6. Châu Chấn Đông
7. Lê Cảnh Duy
8. Lê Đức Anh Đạt
9. Huỳnh Thiện Chí
10. Trần Thiên An
11. Danh Vũ Hào
12. Trần Thị Phương Dung
13. Phan Minh Đức
14. Nguyễn Phạm Nhật Anh
15. Nguyễn Hải Đăng
16. Châu Sóc Chia
17. Lữ Đoàn Phước Bảo
18. Lưu Nữ Kim Đan

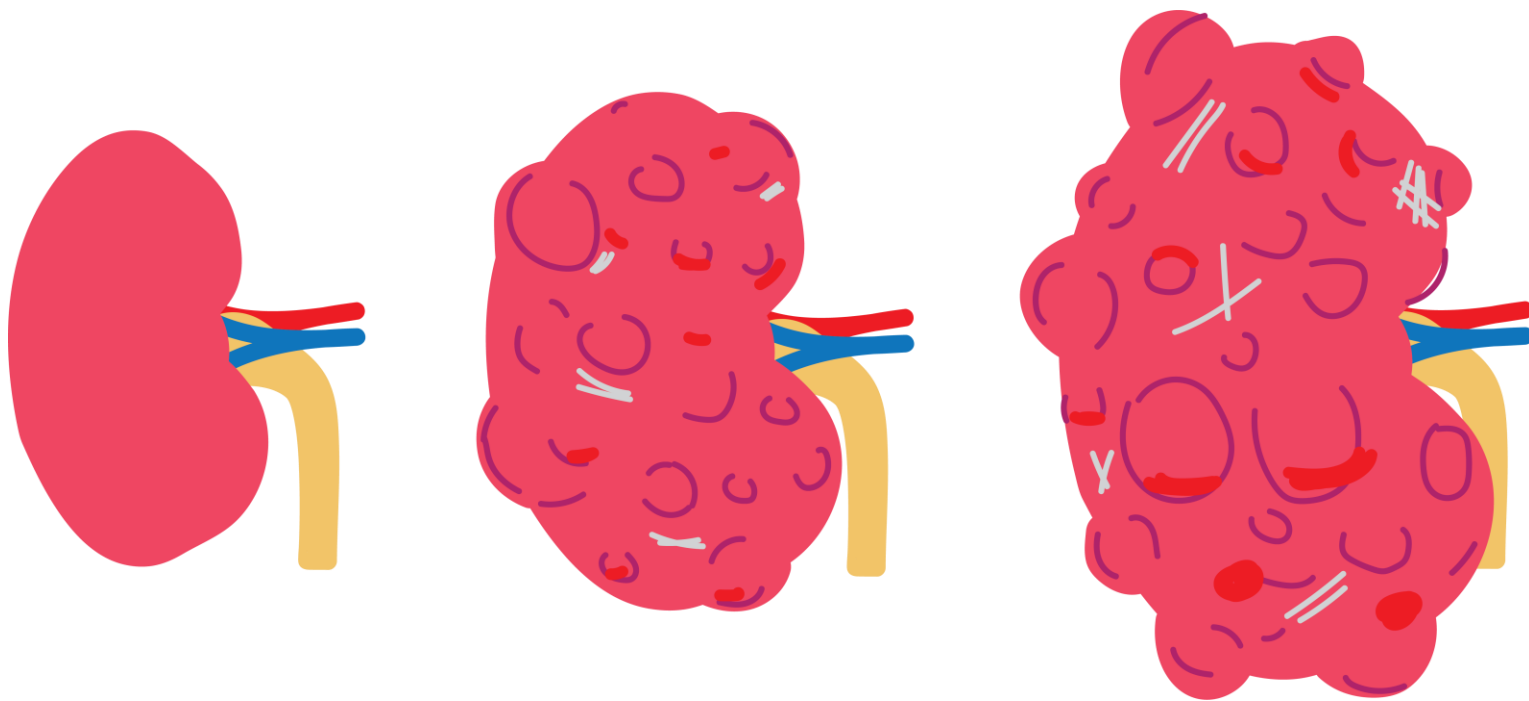


TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH

TRƯỜNG Y DƯỢC

# DINH DƯỠNG TRONG BỆNH THẬN MẠN

GVHD: ThS. Nguyễn Lê Thanh Trúc



# NỘI DUNG

1

**ĐẠI CƯƠNG BỆNH THẬN MẠN**

2

**NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN**

3

**DINH DƯỠNG CHO BỆNH THẬN MẠN**

4

**KHUYẾN CÁO CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN**

5

**PHÒNG NGỪA BỆNH THẬN MẠN**

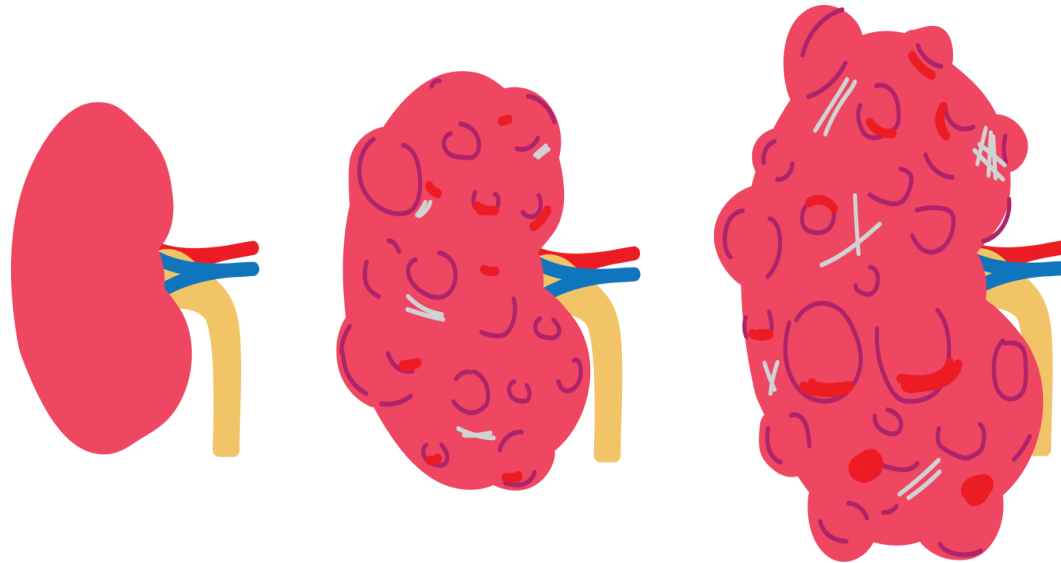
# ĐẠI CƯƠNG BỆNH THẬN MẠN

# MỘT SỐ ĐỊNH NGHĨA VỀ BỆNH THẬN MẠN

**Bệnh thận mạn:** bất thường cấu trúc và chức năng thận kéo dài trên **3 tháng** và ảnh hưởng sức khỏe người bệnh.

**Suy thận mạn:** suy giảm chức năng thận mạn tính không hồi phục kéo dài nhiều tháng, nhiều năm do tổn thương số lượng và chức năng nephron. Tương ứng bệnh thận mạn **giai đoạn 3 – 5**.

**Suy thận mạn giai đoạn cuối:** nặng nề nhất, tích tụ độc chất, nước, điện giải gây HC ure huyết cao, ứng với bệnh thận mạn **giai đoạn 5**.



# DỊCH TỄ BỆNH THẬN MẠN

- Tỷ lệ mắc trong cộng đồng 13%.
- Hiện mắc 700 triệu toàn cầu, 5 - 10 triệu người tử vong mỗi năm, chủ yếu do tim mạch liên quan bệnh thận mạn.
- 2040 CKD là nguyên nhân thứ 5 tử vong.



Ước tính **1 in 10**  
dân số thế giới bị ảnh hưởng  
bởi Bệnh thận mạn<sup>1</sup>



Có ít hơn **5%**  
Người lớn mắc bệnh thận gđ 3  
được chẩn đoán<sup>1-4,a</sup>

REVEAL CKD

Tỷ lệ tử vong  
tăng

**+41.5%**

Từ năm 1990 đến 2017<sup>5</sup>

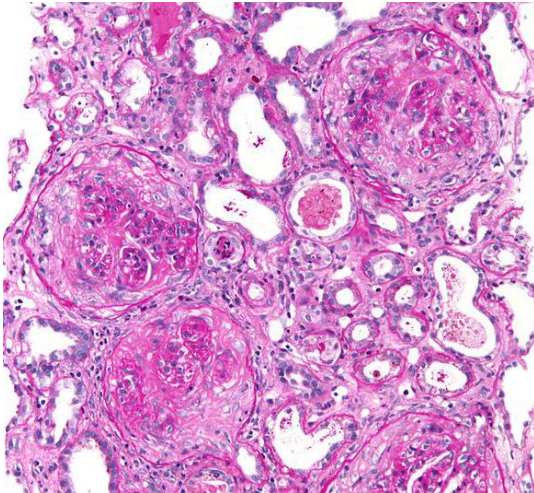




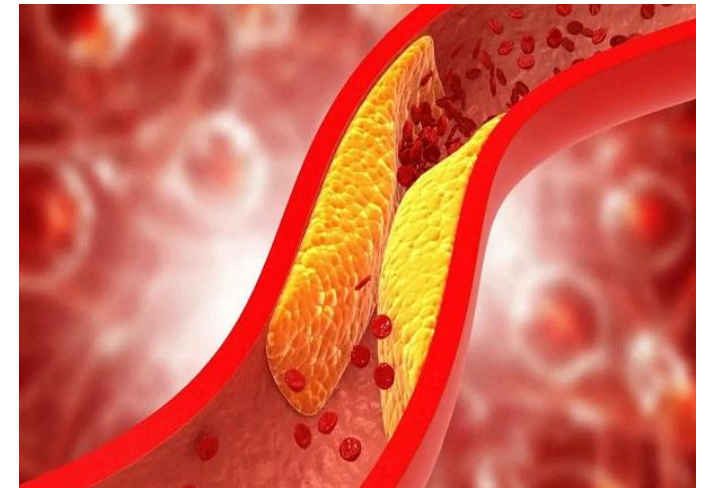
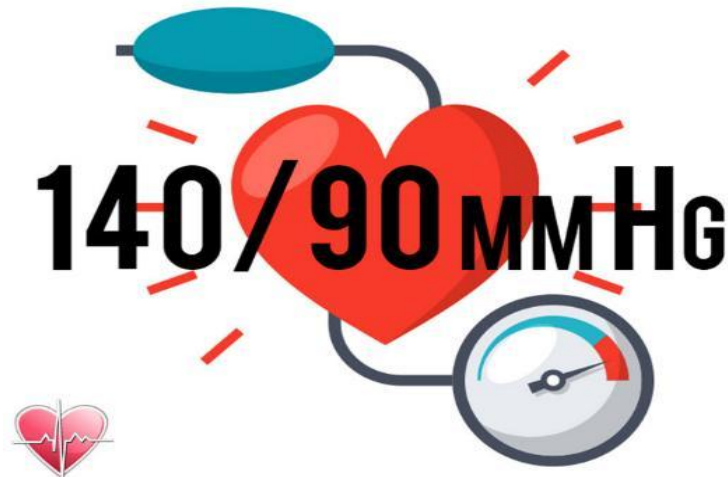
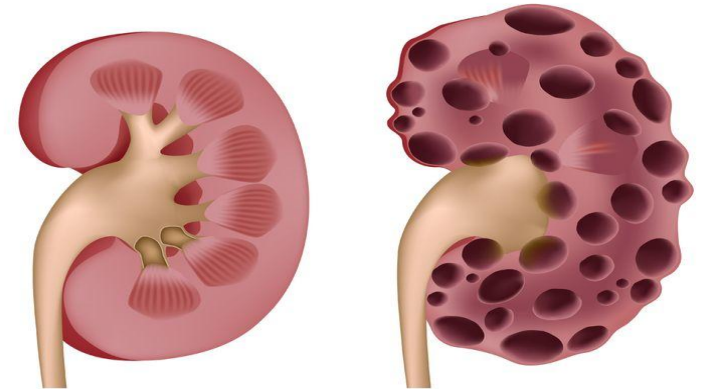
# NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN BỆNH THẬN MẠN

**Nguyên phát:** Viêm cầu thận cấp, sỏi thận, u thận, nang thận...

**Thứ phát:** Đái tháo đường, tăng huyết áp, xơ vữa động mạch...



Polycystic Kidney Disease





# BIẾN CHỨNG CỦA BỆNH THẬN MẠN

## 6 BIẾN CHỨNG SUY THẬN KHÓ LƯỜNG



RỐI LOẠN  
GIẤC NGỦ



CƠ THỂ  
SUY NHƯỢC



LOẠN  
DƯỠNG XƯƠNG



THIẾU MÁU VÀ  
ERYTHROPOIETIN (EPO)



THẬN NGỪNG  
HOẠT ĐỘNG



TỬ VONG



TÂM MINH ĐƯỜNG

*Bệnh suy thận: Nguyên nhân, triệu chứng và cách điều trị từ tự nhiên, Báo lao động, 2018*

## CÁC BIẾN CHỨNG NGUY HIỂM CỦA BỆNH SUY THẬN



Suy tim



Phù não



Phù phổi



Tiểu đường



Cao huyết áp



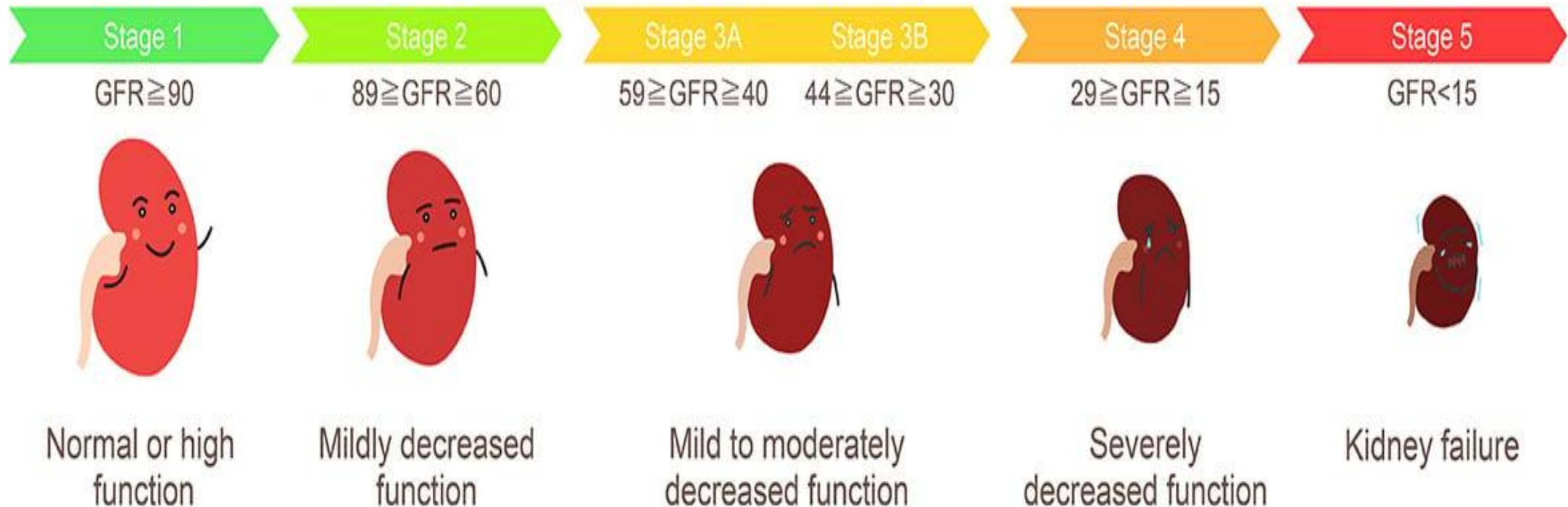
Trào ngược bàng  
quang niệu quản

*Suy thận mạn: nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán và cách điều trị, Medlatec, 2023*



# PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN THEO KDIGO 2012

## 5 Stages Of Kidney Disease



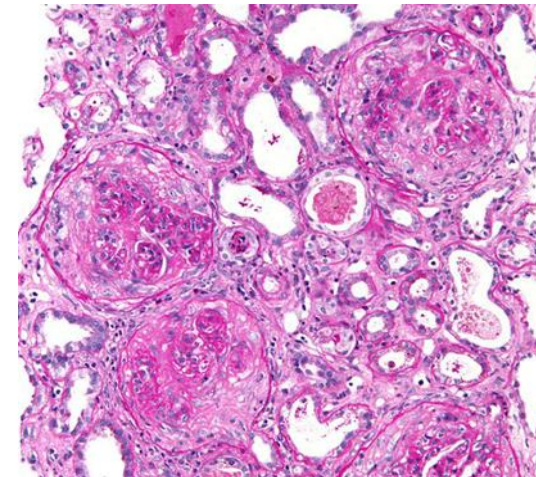
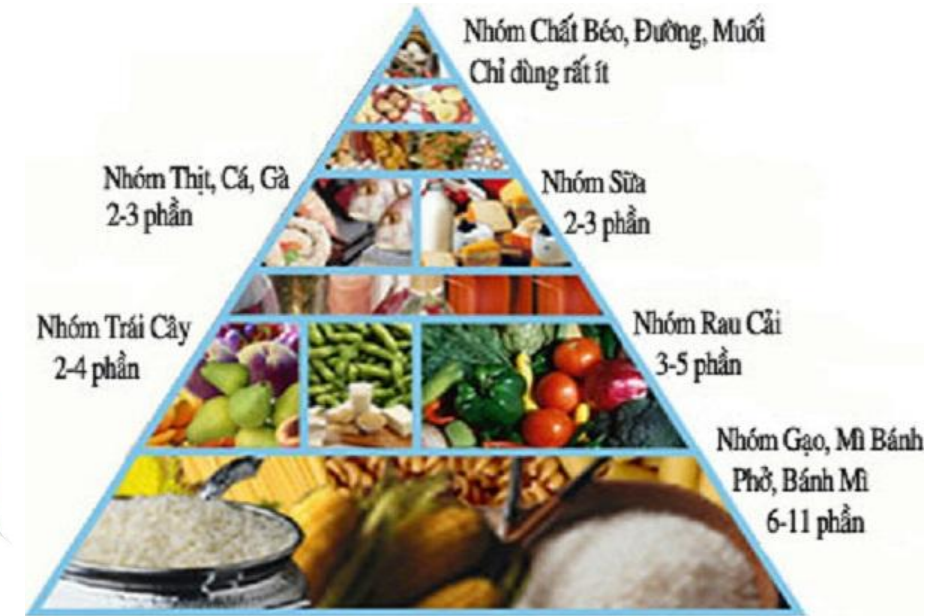
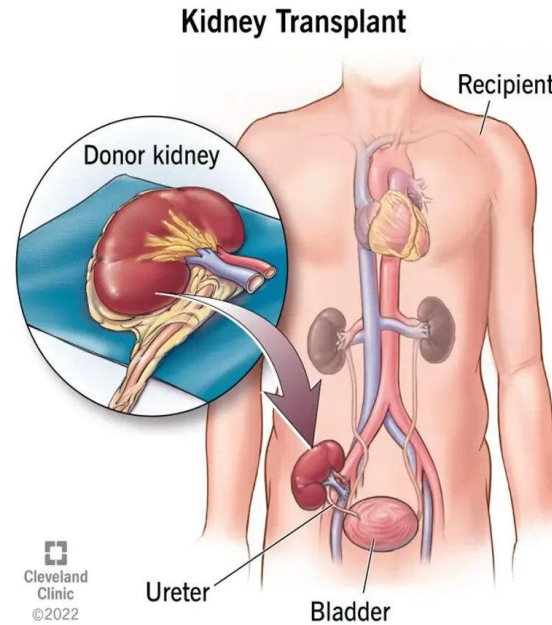
# PHÂN LOẠI BỆNH THẬN MẠN THEO KDIGO 2012

|                                              |     |                   |            | Albumin niệu                |                             |                            |
|----------------------------------------------|-----|-------------------|------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
|                                              |     |                   |            | A1                          | A2                          | A3                         |
|                                              |     |                   |            | Bình thường<br>đến tăng nhẹ | Tăng vừa                    | Tăng nhiều                 |
|                                              |     |                   |            | < 30mg/g<br>< 3mmg/mmol     | 30-300 mg/g<br>3-30 mg/mmol | > 300 mg/g<br>> 30 mg/mmol |
| Độ lọc cầu thận (ml/min/1.73m <sup>2</sup> ) | G1  | Bình thường cao   | 90 trở lên |                             |                             |                            |
|                                              | G2  | Giảm nhẹ          | 60-89      |                             |                             |                            |
|                                              | G3a | Giảm nhẹ đến vừa  | 45-59      |                             |                             |                            |
|                                              | G3b | Giảm vừa đến nặng | 30-44      |                             |                             |                            |
|                                              | G4  | Giảm nặng         | 15-29      |                             |                             |                            |
|                                              | G5  | Suy thận          | < 15       |                             |                             |                            |

# NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN

# NGUYÊN TẮC CHUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN

- Điều trị nguyên nhân.
- Điều trị triệu chứng.
- Ngăn ngừa biến chứng.
- **Làm chậm tiến triển bệnh.**
- Điều trị dinh dưỡng.
- Thay thế thận...





# NGUYÊN TẮC ĐIỀU TRỊ BỆNH THẬN MẠN THEO GIAI ĐOẠN

| Giai đoạn | Mức lọc cầu thận<br>(ml/ph/1,73 | Việc cần làm (*)                                                                                                                                 |
|-----------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | $\geq 90$                       | Chẩn đoán và điều trị bệnh căn nguyên, giới hạn yếu tố nguy cơ gây suy thận cấp, làm chậm tiến triển bệnh thận, điều trị yếu tố nguy cơ tim mạch |
| 2         | 60-89                           | + Ước đoán tốc độ tiến triển bệnh thận                                                                                                           |
| 3         | 30-59                           | +Đánh giá và điều trị biến chứng                                                                                                                 |
| 4         | 15-29                           | + Chuẩn bị điều trị thay thế thận                                                                                                                |
| 5         | $\leq 15$                       | Điều trị thay thế thận nếu có hội chứng uré huyết                                                                                                |

(\*) giai đoạn sau tiếp tục việc của giai đoạn trước

# NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG CHUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY THẬN MẠN

- Giàu năng lượng. (35 - 40 kcalo/kg/ngày)
- Giảm protein (0,6 -0,8g/kg/ngày)
- Đủ vitamin, yếu tố vi lượng
- Đảm bảo cân bằng nước, natri.
- Giàu canxi - Ít phosphat.
- Hạn chế các chất kích thích.

# NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG CHUNG ĐIỀU TRỊ BỆNH SUY THẬN MẠN

## NGUYÊN TẮC CHUNG TRONG CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI SUY THẬN



## CHẾ ĐỘ DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI SUY THẬN



### 1 Người suy thận nên ăn nhạt



Những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt và không nên ăn quá 2 – 4g muối mỗi ngày. Khi cả hai thận đều bị suy, muối sẽ không được loại bỏ mà ứ lại trong cơ thể gây phù, cao huyết áp, suy tim, ứ nước trong phổi và tổn thương các mạch máu...

### 2 Giảm lượng Kali trong các bữa ăn



Ở người suy thận, nếu không kiểm soát lượng kali ăn vào thì dễ xảy ra hiện tượng kali máu tăng cao, bệnh nhân có thể tử vong do loạn nhịp tim. Khi kali máu >5mmol/Lít, bệnh nhân cần chế độ ăn giảm kali để làm chậm sự tích tụ của chất thải trong máu...

### 3 Cung cấp lượng nước hợp lý



Nếu bệnh nhân suy thận uống nhiều nước, lượng nước dư thừa sẽ là nguyên nhân góp phần làm tăng huyết áp, phù phổi cấp, gây chứng khó thở, tràn dịch các khoang màng bụng, màng phổi, màng ngoài tim...

### 4 Thực đơn cho người suy thận mạn nên giảm hàm lượng Phospho(P)



Thức ăn chứa nhiều phospho làm tăng lượng phospho trong máu ở người suy thận giai đoạn cuối do thận đã mất khả năng đào thải phospho. Khi lượng phospho tăng cao sẽ làm xương mất canxi và gây loãng xương.



# NGUYÊN TẮC VỀ CÁC THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG BỆNH THẬN MẠN

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ DINH DƯỠNG, 2001 - 2010

## NGUYÊN TẮC:

**Giàu năng lượng:** 35 Kcal/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

(Cân nặng lý tưởng = số lẻ chiều cao x 0,9; ví dụ người cao 160 cm, cân nặng lý tưởng sẽ bằng 60 x 0,9 = 54kg).

## Protid:

Suy thận giai đoạn 1-2: 0,6-0,8 g/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

Giai đoạn 3-4: 0,4-0,6g/kg cân nặng lý tưởng/ngày.

Tỷ lệ protid động vật/tổng số  $\geq 60\%$

**Lipid:** 20- 25% tổng năng lượng. Acid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và acid béo no chiếm 1/3 trong tổng số lipid.

## Đảm bảo cân bằng nước và điện giải:

**Ăn nhạt tương đối:** Natri < 2000 mg/ngày

## Kali:

Giai đoạn 1-2: Hạn chế kali khẩu phần 2000-3000 mg/ngày khi kali máu >6 mmol/l ; Hạn chế hoặc sử dụng vừa phải các thực phẩm giàu kali.

Giai đoạn 3-4 (tăng kali máu): kali khẩu phần < 1000mg/ ngày.

## Hạn chế nước ăn và uống khi có chỉ định:

$V \text{ nước} = V \text{ nước tiểu} + V \text{ dịch mất bất thường (sốt, nôn, ỉa chảy...) } + 300 \text{ đến } 500\text{ml (tùy theo mùa)}.$

**Phosphat:** < 1200mg/ngày. Hạn chế các thực phẩm giàu phosphat.

**Đủ vitamin và khoáng chất;** nhất là sắt và acid folic vì bệnh nhân suy thận thường có thiếu máu kèm theo.

**Số bữa ăn:** 4 bữa/ngày



**Thực phẩm không nên dùng nhiều:** đậu đỗ, gạo, mỳ...

## Thực phẩm hạn chế:

Thức ăn có phosphat như gan, bầu dục, tim, não, tủy sống...

Hạn chế ăn các loại rau có nhiều đạm thực vật như: giá đỗ, rau muống, rau ngót, đậu quả...

## Thực phẩm nên dùng:

Các thực phẩm là nguồn protein quý như: trứng, sữa, cá, thịt nạc...

Các chất bột ít đạm thực vật như sắn, khoai lang, khoai sọ, khoai tây, miến dong, bột sắn dây...

Rau ít đạm, ít chua như cải các loại, dưa chuột, bầu bí, mướp...

Các loại quả ngọt ít chua như nhãn, na, đu đủ, chuối chín...



VIỆN DINH DƯỠNG

TRUNG TÂM GIÁO DỤC TRUYỀN THÔNG DINH DƯỠNG \*Địa chỉ: 48B - Tầng Bạt Hố - Hà Nội \*ĐT: 84-4-9720608 \*E-mail: viendinhduong@hn.vnn.vn \*Website: <http://www.nutrition.org.vn>



# NGUYÊN TẮC QUAN TRỌNG NHẤT



**CÁ THỂ HÓA**

# NHU CẦU DINH DƯỠNG



# MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC



Tĩnh tại

Nhẹ

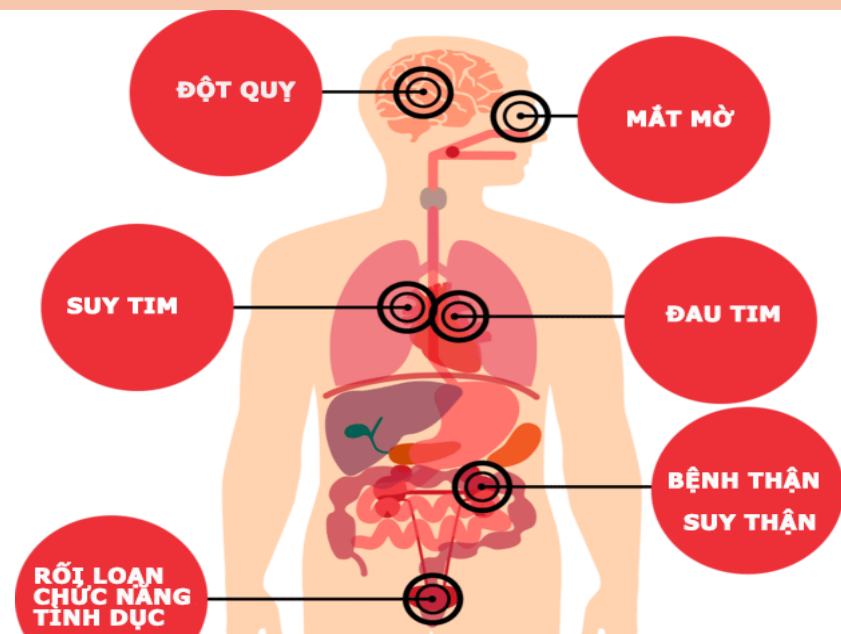
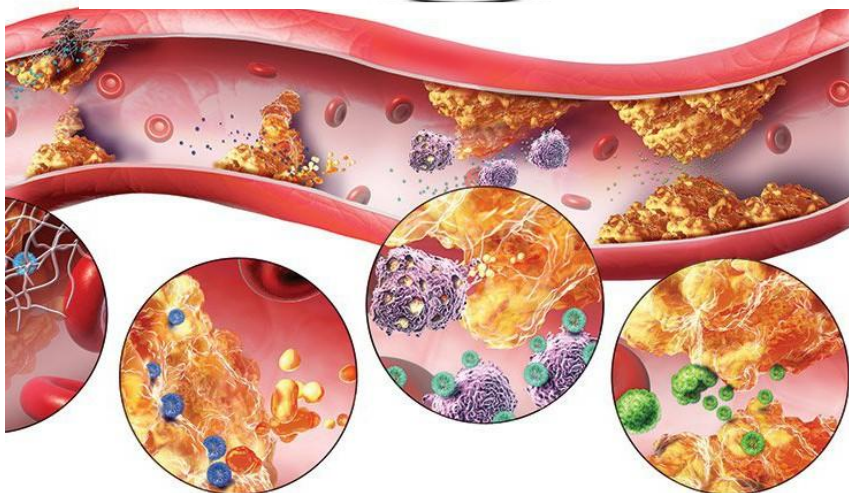
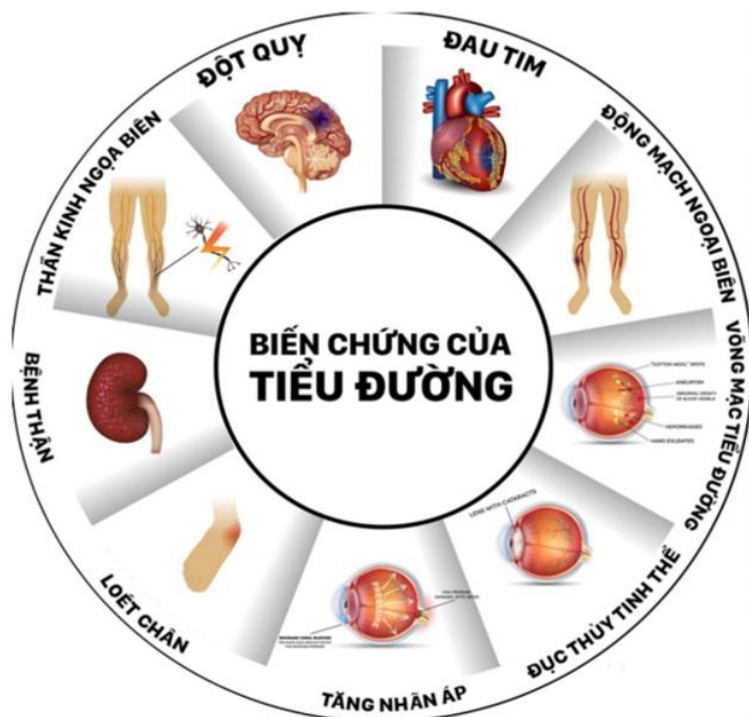
Trung bình

Nặng

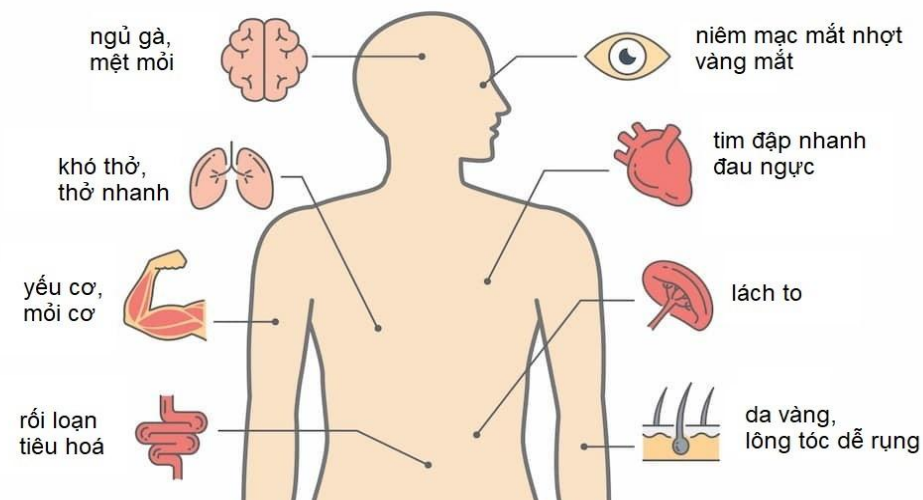




# BỆNH LÝ KÈM THEO



TRIỆU CHỨNG THIẾU MÁU  
(đa dạng, tùy thuộc vào cơ quan)



# GIẢI ĐOẠN BỆNH

- Tùy từng giai đoạn cụ thể sẽ có nguyên tắc dinh dưỡng riêng.
- **Mục đích:** kéo dài chức năng thận, ngừa biến chứng, cung cấp đủ dinh dưỡng theo từng giai đoạn...
- Đảm bảo **chất lượng cuộc sống** cho người bệnh.



# **DINH DƯỠNG CHO BỆNH THẬN MẠN**



# CHẾ ĐỘ ĂN TRONG BỆNH THẬN MẠN

- Ngăn ngừa thiếu dinh dưỡng và duy trì dinh dưỡng tốt.
- Kiểm soát phù và mất cân bằng dịch.
- Ngăn ngừa và làm chậm loạn dưỡng xương thận.
- Cho bệnh nhân chế độ ăn ngon miệng, hấp dẫn, phù hợp lối sống...



# THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG

- Protid.
- Glucid.
- Lipid.
- Muối.
- Kali.
- Phosphat.
- Nước.
- Vitamin và khoáng chất.



# PROTID – NGUỒN SỐNG HAY GÁNH NẶNG?

## Nguồn sống

- Chức năng sống còn: cung cấp aa xây dựng cơ, da, hormon...
- Chống suy dinh dưỡng.
- Duy trì miễn dịch

## Gánh nặng

- Chuyển hóa protid sinh hợp chất chứa nitơ ure, creatinin, acid uric...
- Suy thận không lọc được chất độc → tăng trong máu → tăng ure máu, nhiễm độc

# PROTID

→ Quan trọng nhất.

- **Khuyến nghị hiện hành của KDIGO 2012:** hạn chế protein cho những bệnh nhân bệnh thận mạn tính, **protein < 0,8 g/kg/ngày** với bệnh nhân bệnh thận có **đái tháo đường** hoặc bệnh thận không có đái tháo đường nhưng có **mức lọc cầu thận < 30 ml/phút/1,73 m<sup>2</sup>**, **tránh** chế độ ăn có hàm lượng **protein > 1,3 g/kg/ngày** ở những bệnh nhân có **bệnh thận mạn tiến triển**.
  - Chế độ ăn **quá hạn chế protein < 0,4 g/kg/ngày** không giúp cải thiện tiến triển bệnh thận mà còn **tăng nguy cơ tử vong**.
- Lượng protein vừa đủ.



# PROTID

- **Hội thận học Hoa kỳ:**

- **Không lọc máu:**

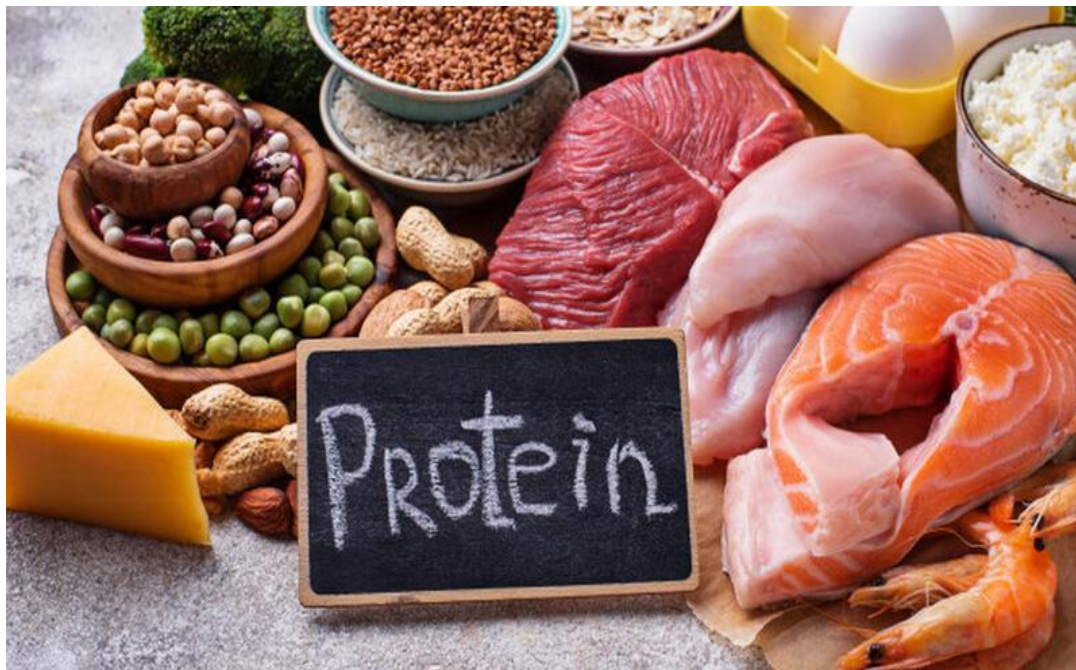
- + Suy thận độ **I: 0,8 – 1 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày
    - + Suy thận độ **II: 0,7 – 0,8 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày
    - + Suy thận độ **III: 0,6 – 0,7 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày
    - + Suy thận độ **IV: 0,5 – 0,6 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày
    - + Suy thận độ **V: 0,4 – 0,5 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày

- **Lọc máu:**

- + Lọc máu ngoài thận chu kỳ: **1,2 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày
    - + Thẩm phân phúc mạc: **1,2 – 1,5 g/kg** cân nặng lý tưởng/ngày

# PROTID

- **Hội thận học Nhật Bản (2014):** *Giai đoạn 3b - 5* lượng protein khẩu phần nên từ **0,6 - 0,8 g/kg** cân nặng lí tưởng.
- Đảm bảo **50-60% protein có giá trị sinh học cao**, để đảm bảo dễ tiêu hóa và hấp thu các acid amin.





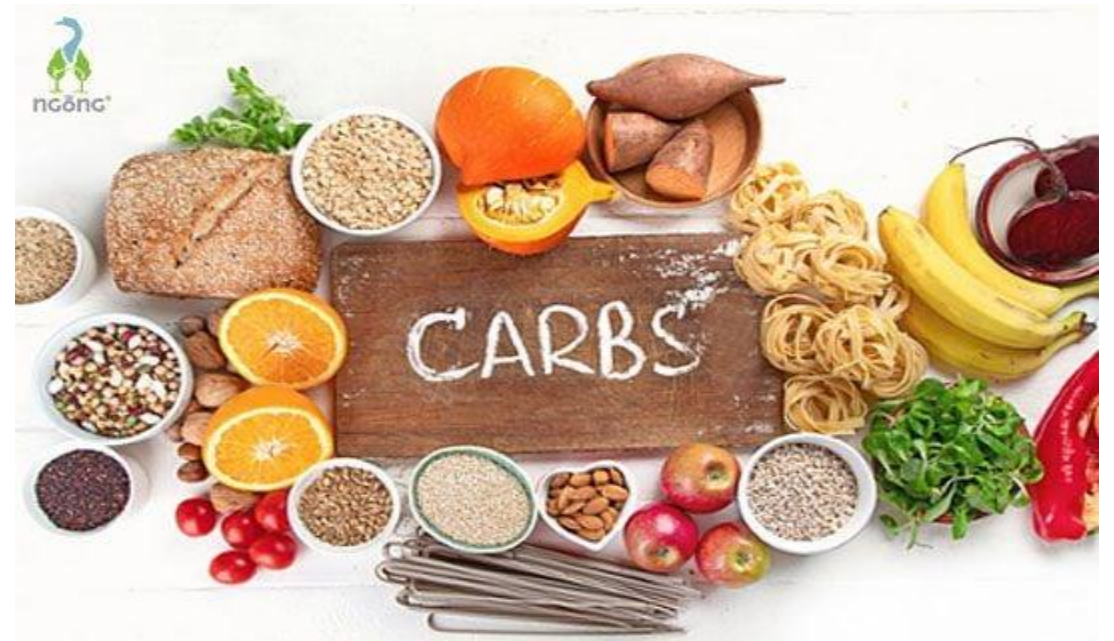
# PROTID

- Tỷ lệ **protid động vật/tổng số  $\geq 50\%$**
- Nên sử dụng protid chứa nhiều acid amin cần thiết như: thịt bò, thịt gà, lợn, cá, tôm, sữa...
- **Hạn chế protid từ thực vật như: đậu đỗ, vừng, lạc...**
- Hạn chế thực phẩm **chứa phosphat như gan, trứng...**
- **Ăn nhiều thức ăn chứa canxi** như tôm, cá, sụn...



# NĂNG LƯỢNG

- **30 – 35 kcal/cân nặng lý tưởng/ngày.**
- Đủ năng lượng, giảm thoái giáng protein cơ thể.
- Nguồn năng lượng ở bệnh nhân mắc bệnh thận mạn **chủ yếu từ lipid và glucid.**





# LIPID

- Vấn đề quan trọng trong **rối loạn chuyển hóa lipid** ở bệnh nhân mắc CKD là **bệnh lý tim mạch**.
  - Thuốc điều trị rối loạn chuyển hóa lipid máu kết hợp với chế độ ăn hạn chế cholesterol giúp làm giảm cholesterol tổng số, giảm LDL cholesterol và triglyceride.
  - Chế độ ăn hạn chế protein cũng đồng thời giúp làm giảm tổng lượng chất béo và protein có nguồn gốc động vật.
- Sử dụng lipid vừa đủ trong khẩu phần ăn, đặc biệt nên sử dụng thực phẩm chứa acid béo không no nhiều nối đôi.**



# 17 LOẠI THỰC PHẨM GIÚP GIẢM MỠ MÁU





# GLUCID

- **Nên** sử dụng tối đa các thực phẩm **giàu glucid nhưng ít đạm** như: sắn, khoai lang, khoai sọ, khoai tây, miếng rong, bột sắn dây...
- **Nên** sử dụng **đường, mật mía, mật ong, kẹo ngọt...**
- **Không ăn** nhiều các loại **ngũ cốc chứa nhiều đạm** như gạo, mì...





# MUỐI

- Biến chứng bệnh thận mạn: **Tăng huyết áp.**
- McMahon (2015): ↓ muối → ↓ tổng lượng muối nước tiểu 24h, huyết áp, liều thuốc tăng huyết áp, bài tiết protein niệu, 56% nguy cơ phù.
- Hội thận học Nhật Bản (2014): **hạn chế lượng muối < 2400mg/ngày.**
- Mục đích: **Giảm thải protein qua nước tiểu và giảm nguy cơ tiến triển** của bệnh thận giai đoạn cuối, giảm nguy cơ các bệnh tim mạch và tử vong.



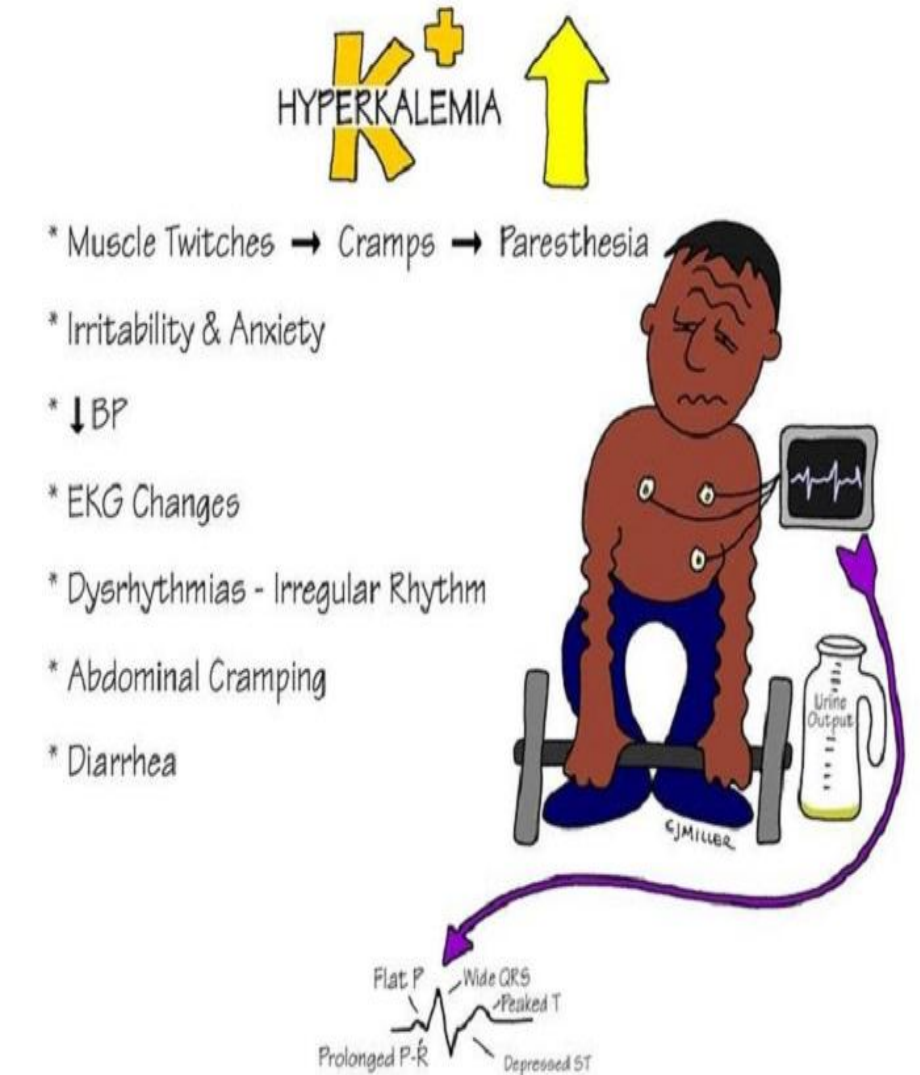
# MUỐI

- Hội thận học Nhật Bản (2014): **không nên <1200 mg/ngày.**
- Giảm quá nhiều muối, sử dụng thuốc lợi niệu → Hạ huyết áp  
→ Cục máu đông, chức năng thận xấu đi → tăng nguy cơ tiến triển tới bệnh thận giai đoạn cuối và tử vong.



# KALI

- Khi lượng nước tiểu **<1L/ngày** cần **áp dụng chế độ ăn hạn chế kali.**
- Tại sao?
- Bình thường lượng Kali đưa vào cơ thể được thận đào thải ra ngoài theo nước tiểu, khi lượng nước tiểu **<1L/ngày** → Chức năng thận suy giảm → Không lọc được Kali và các chất độc → **Tăng Kali máu** (cấp cứu nội khoa) → Ngưng tim.





# PHOSPHAT

- Cơ chế đào thải phosphat giống với kali.
- Hậu quả tăng phosphate máu:
  - + **Hạ canxi máu** (do phosphate gắn với canxi) → co giật, dị cảm, chuột rút.
  - + **Cường cận giáp thứ phát** → huy động canxi từ xương → loãng xương, biến dạng, gãy xương.
  - + **Lắng đọng canxi - phosphate** ở mô mềm, mạch máu, tim, phổi → vôi hóa, xơ vữa, tăng nguy cơ tim mạch.
  - + **Tăng nguy cơ tử vong** do kết hợp canxi gây vôi hóa mạch máu.



# NƯỚC

- Người bình thường: **2 lít/ngày.**
- Người suy thận mạn: nước rất quan trọng. Kiểm soát tốt lượng nước → Bệnh nhân có chất lượng cuộc sống tốt hơn.
- Bao nhiêu là đủ? → Tùy từng giai đoạn.

**KAROFI**  
karofivietnam.com.vn

**LỢI ÍCH**  
CỦA VIỆC **UỐNG**  
**2 LÍT NƯỚC**  
**MỖI NGÀY**

-  **Đẹp da**
-  **Đào thải độc tố**
-  **Cơ thể không mất nước**
-  **Cải thiện hệ tiêu hoá**

Triệu chứng của tình trạng phù do suy thận



Phù mắt cá chân



Phù mí mắt



Phù chân



# VITAMIN VÀ KHOÁNG CHẤT

- KDIGO 2017: khuyến nghị nên theo dõi nồng độ calci, phospho, PTH và hoạt động của alkaline phosphatase từ khi bắt đầu giai đoạn CKD G3a mỗi 1-3 tháng, 3-6 tháng hay 6-12 tháng tùy giai đoạn của bệnh. Bệnh nhân có các bất thường cần được điều trị phù hợp.
- Bổ sung vitamin tan trong nước (B,C) hàng ngày do phải hạn chế rau quả và sữa ngoài ra vitamin nhóm B, C còn mất do quá trình lọc máu, do đó chế độ ăn có thể thiếu các vitamin này.





# THÀNH PHẦN DINH DƯỠNG TRONG BỮA ĂN THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA BỆNH THẬN MẠN

- Suy thận mạn giai đoạn 1 – 2.
- Suy thận mạn giai đoạn 3 – 4, không lọc máu, không tăng kali máu.
- Suy thận mạn giai đoạn 3 – 4, không lọc máu, tăng kali máu.
- Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 1 lần/tuần.
- Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 2 lần/tuần.
- Suy thận mạn có lọc máu ngoài thận hoặc thẩm phân phúc mạc 3 lần/tuần.

# SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 1 - 2

E (kcal): 1800 – 1900

P (g): 40- 44

L (g): 40- 50

G (g): 313- 336

Natri (mg): <2000

Kali (mg): 2000-3000

Phosphat (mg):<1200

Nước (l): 1- 2.

|                               | Bữa sáng                                | Bữa trưa                                | Bữa chiều                               | Bữa phụ                                                          |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Tinh bột</b>               | Miến dong khô: 60g                      | Cơm gạo lứt: 1 chén                     | Cơm gạo lứt: 1 chén                     | – Sữa cho người bị suy thận: 100ml<br><br>– Khoai lang hấp: 120g |
| <b>Đạm</b>                    | Mực: 30g                                | Cá hồi áp chảo: 50g                     | Gà kho gừng: 50g                        |                                                                  |
| <b>Chất xơ</b>                | – Cải ngọt: 50g<br>– Ớt chuông: 40g     | Canh bí xanh: 100g                      | Bầu luộc: 100g                          |                                                                  |
| <b>Chất béo</b>               | Đã được bổ sung trong món chính         | Đã được bổ sung trong món chính         | Đã được bổ sung trong món chính         | – Sữa cho người bị suy thận: 100ml<br><br>– Táo: 200g            |
| <b>Vitamin và khoáng chất</b> | Đã được bổ sung trong món chính         | Đã được bổ sung trong món chính         | Đã được bổ sung trong món chính         |                                                                  |
| <b>Gia vị</b>                 | Tuân thủ nguyên tắc hạn chế muối, đường | Tuân thủ nguyên tắc hạn chế muối, đường | Tuân thủ nguyên tắc hạn chế muối, đường |                                                                  |
| <b>Món ngon gợi ý</b>         | Miến dong xào mực                       | Cơm cá hồi áp chảo và canh bí xanh      | Cơm gà kho gừng và bầu luộc             |                                                                  |

# SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3 – 4 KHÔNG LỌC MÁU KHÔNG TĂNG KALI MÁU

- E (kcal): 1800-1900
- P (g): < 33
- L (g): 40- 50
- G (g): 310- 350
- Natri (mg) : < 2000
- Phosphat (mg):<1200
- Nước (lít): 1- 1,5

|                               | Bữa sáng                                                            | Bữa trưa                                                              | Bữa chiều                                                                                      | Bữa phụ                          |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Tinh bột</b>               | – Cháo khoai lang<br>– 1 lát bánh mì ngũ cốc                        | – Cơm trắng                                                           | – Súp nấm hương bắp cải                                                                        | Tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ |
| <b>Đạm</b>                    | x                                                                   | – Cá                                                                  | –Ức gà                                                                                         |                                  |
| <b>Chất xơ</b>                | x                                                                   | – Rau muống<br>– Bầu                                                  | – Rau bí                                                                                       |                                  |
| <b>Chất béo</b>               | x                                                                   | x                                                                     | – Dầu oliu                                                                                     | Tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ |
| <b>Vitamin và khoáng chất</b> | Nước ép lê                                                          | Nho                                                                   | Nước ép dâu tây                                                                                |                                  |
| <b>Gia vị</b>                 | Tùy chỉnh theo hướng dẫn từ bác sĩ                                  | Tùy chỉnh theo hướng dẫn từ bác sĩ                                    | Tùy chỉnh theo hướng dẫn từ bác sĩ                                                             |                                  |
| <b>Món ăn gợi ý</b>           | Cháo khoai lang ăn kèm bánh mì ngũ cốc và uống thêm 1 ly nước ép lê | Rau muống và bầu luộc bỏ nước, cá kho tiêu nhạt, tráng miệng bằng nho | Súp nấm hương bắp cải, ăn kèm ức gà nướng dầu oliu, rau bí xào, uống thêm 1 ly nước ép dâu tây | x                                |



# SUY THẬN MẠN GIAI ĐOẠN 3 – 4 KHÔNG LỌC MÁU CÓ TĂNG KALI MÁU

- E (kcal): 1800- 1900
- P (g): < 33
- L (g): 40-50
- G (g): 310-350
- Natri(mg):1000-2000
- Kali (mg): < 1000
- Phosphat (mg): < 600
- Nước (l): 1- 1,5

| Bữa ăn | Món ăn (chế biến giảm K: ngâm, luộc bỏ nước) | Khối lượng (g/ml) | Ghi chú                |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| Sáng   | Cơm trắng                                    | 120 g gạo         | Năng lượng chính       |
|        | Trứng gà luộc                                | 1/2 quả (~25 g)   | Protein chất lượng cao |
|        | Bí đỏ hấp                                    | 50 g              | Ít kali, vitamin       |
|        | Táo gọt vỏ                                   | 80 g              | Trái cây ít kali       |

|           |                          |              |                           |
|-----------|--------------------------|--------------|---------------------------|
| Trưa      | Cơm trắng                | 150 g gạo    | Glucid                    |
|           | Cá basa hấp gừng         | 50 g         | Đạm động vật dễ tiêu      |
|           | Đậu hũ hấp               | 60 g         | Bổ sung đạm thực vật ít P |
|           | Bầu luộc (ngâm bỏ nước)  | 100 g        | Rau ít kali               |
|           | Dầu thực vật             | 1 thìa (5 g) | Lipid tốt                 |
| Phụ chiều | Bánh mì trắng            | 40 g         | Glucid                    |
|           | Nước ép táo (lọc trong)  | 100 ml       | ít kali                   |
| Tối       | Cơm trắng                | 120 g gạo    | Glucid                    |
|           | Thịt gà nạc luộc (bỏ da) | 40 g         | Protein động vật          |
|           | Bí xanh luộc             | 80 g         | ít kali                   |
|           | Dầu thực vật             | 1 thìa (5 g) | Lipid                     |

# SUY THẬN MẠN CÓ LỘC MÁU NGOÀI THẬN HOẶC THÂM PHÂN PHỨC MẠC

## *1 lần/tuần*

- E (kcal): 1800- 1900
- ***P (g): 40- 44***
- ***L (g): 40- 53***
- ***G (g): 313- 336***
- Natri (mg): < 2000
- Kali (mg): 1000- 1500
- ***Phosphat (mg): < 800***
- Nước (l): 1- 1,5

## *2 lần/tuần*

- E (kcal): 1800-1900
- ***P (g): 50-55***
- L (g): 40-50
- ***G (g): 290-325***
- Natri(mg): 2000-4000
- Kali (mg): 2000-3000
- Phosphat (mg): <1200
- Nước (l): 1-1,5

## *3 lần/tuần*

- E (kcal): 1800-1900
- ***P (g): 60-70***
- L (g): 40-50
- ***G (g): 280-314***
- Natri(mg): 2000-4000
- Kali (mg): 2000-3000
- Phosphat (mg): <1200
- Nước (l): 1-2



# DASHdiet

**6-8**

khẩu phần ngũ cốc  
nguyên hạt mỗi ngày

**4-5**

khẩu phần rau củ  
mỗi ngày

**4-5**

khẩu phần hoa quả  
mỗi ngày

**2-3**

khẩu phần sản phẩm  
bơ sữa không béo  
hoặc ít béo



**4-5**

khẩu phần các loại  
hạt, đậu mỗi tuần

**ít hơn 6**

khẩu phần thịt gia súc,  
gia cầm, cá mỗi ngày

**ít hơn 5**

khẩu phần đồ ngọt  
mỗi tuần

**2-3**

khẩu phần chất béo  
và dầu mỗi ngày







# DINH DƯỠNG cho người bệnh **THẬN MẠN**



*"Hãy để thức ăn làm thuốc  
và hãy để thuốc làm thức ăn"*

*-Hippocrates-*

**1**

## BỆNH THẬN MẠN VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG?

### Khái niệm

Bệnh thận mạn là hậu quả cuối cùng của các bệnh thận và bệnh ngoài thận, gây giảm từ từ số lượng và chức năng các nephron, dẫn tới suy thận giai đoạn cuối đòi hỏi điều trị thay thế thận.

### Các triệu chứng đặc trưng liên quan tới dinh dưỡng

- + Phù, tăng huyết áp.
- + Tăng kali, tăng phospho máu.
- + Bệnh xương do thận do rối loạn chuyển hoá vitamin D, canxi, phospho.
- + Thiếu máu.
- + Chán ăn, kiếng khem.
- + Tình trạng viêm và các đặc trưng do bệnh nền gây bệnh thận mạn.

### Vai trò dinh dưỡng

Một chế độ dinh dưỡng đúng và hợp lý là một phần quan trọng trong phác đồ điều trị bệnh, góp phần làm chậm sự tiến triển của bệnh tới giai đoạn cuối, nâng cao tình trạng dinh dưỡng và chất lượng sống cho người bệnh.



**2**

## NGUYÊN TẮC DINH DƯỠNG

### Năng lượng

30-35kcal/cân nặng nền cơ/ngày

### Đạm (Protein)

Tùy theo giai đoạn của bệnh thận mạn, trong đó tỉ lệ đạm từ động vật nên chiếm > 50% tổng lượng đạm.

### Không lọc máu

- + Độ 1: 0,8 g/kg/ngày.
- + Độ 2: 0,6g/kg/ngày.
- + Độ 3-4: 0,55g/kg/ngày.

### Có lọc máu

- + Chạy thận nhân tạo: 1,2-1,4 g/kg/ngày.
- + Thẩm phân phúc mạc: 1,4-1,5 g/kg/ngày.
- + Nếu bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng: 1,5-2 g/kg/ngày.

### Chất béo (Lipid)

Nên chiếm từ 20 - 25% tổng năng lượng, trong đó acid béo chưa no một nối đôi chiếm 1/3, nhiều nối đôi chiếm 1/3 và acid béo no chiếm 1/3 tổng số béo.

### Tinh bột (Glucid)

Nên sử dụng các thực phẩm ít chất đạm, nhất là khoai củ và các sản phẩm chế biến từ khoai củ (miến dong, bột sắn dong...).

- Chế độ ăn đa dạng đầy đủ các vitamin và chất khoáng.
- Nên chọn thực phẩm giàu sắt, vitamin B12, vitamin B6...
- Các vitamin nhóm B để chuyển hoá năng lượng của khẩu phần.
- Dùng các loại rau, quả nhưng nên giảm loại rau có hàm lượng đạm cao





**Thức ăn nên dùng**

- Khoai củ và các sản phẩm chế biến từ khoai củ như: miến dong, bột sắn dây, bột sắn dong...
- Thực phẩm giàu omega-3.
- Chất béo chưa no thay cho chất béo bão hòa.
- Trứng, sữa, thịt gà, thịt lợn nạc, thịt bò, cá, tôm, đậu nành, đậu phụ.
- Rau xanh ít đạm: bầu bí, mướp, cà chua, dứa, mùng, su su.
- Ưu tiên ăn rau củ hơn là rau lá vì có hàm lượng Kali thấp.

**Thức ăn nên hạn chế**

- Những thức ăn giàu protein thực vật: đậu đỏ (trừ đậu nành).
- Các rau quả chua, rau quả chứa nhiều Kali.
- Thức ăn chế biến chứa nhiều muối: cà chua, dưa muối, cá thịt kho mặn.
- Các loại chất kích thích: rượu, bia, cà phê.
- Thức ăn/ đồ uống chứa nhiều Phospho



Người bệnh thận mạn bị giảm khả năng đào thải ure, natri, kali, và nước... gây ứ đọng các chất này trong máu vì vậy chế độ ăn cần lưu ý, hạn chế dùng các thực phẩm giàu các chất này.

**Hạn chế thực phẩm giàu Natri**

- + Khi có phù, tăng huyết áp nên lựa chọn thực phẩm có lượng Natri thấp.
- + Gia vị nêm, chấm: muối, xì dầu, nước mắm, mì chính...
- + Thức ăn đông hộp, đông lạnh, chế biến sẵn: xúc xích, thịt muối...
- + Thức ăn nhanh và các loại ngâm muối dầm.
- + Ăn nhạt khi có phù, tăng huyết áp, suy tim.
- + Chọn những thực phẩm có tính kiềm, thực phẩm chứa nhiều.
- + Calci sẽ có tính kiềm và ngược lại nếu chứa nhiều P sẽ có tính acid.
- + Hạn chế cung cấp nước quá nhu cầu cơ thể.
- + Lượng nước hàng ngày = lượng nước tiểu/24 giờ + (500 - 700ml) ở người lớn.
- + Lượng nước hàng ngày = lượng nước tiểu/24 giờ + (200 - 300ml) ở trẻ em.
- + Lượng nước cộng thêm nhiều hay ít tùy thuộc mùa hè hay mùa đông hoặc bệnh nhân bị mất nước do bệnh lý như tiêu chảy, sốt, nôn...



Năng lượng 1880cal, 41g đạm, 41g chất béo, 336g tinh bột, Natri 226mg, Phosphat 801mg, Kali 776mg, Canxi 376mg

**Bữa sáng**

Bún thịt gà bún 150g, thịt gà 20g, hành lá rau thơm.

**Phụ sáng**

Sữa thận: 200-400kcal.

**Bữa trưa**

Súp thịt nạc: khoai tây 50g, su hào 30g, miến dong 30g, bột sắn dây 30g, thịt nạc 20g, dầu thực vật 5g.

**Phụ chiều**

Hoa quả: Thanh long 200g.

**Bữa tối**

Cơm miến, trứng cà chua, bí xanh luộc: Gạo tẻ máy 30g, miến dong 130g, trứng gà 70g, cà chua 80g, dầu thực vật 5g.

**Phụ tối**

Sữa thận: 200-400kcal.

**LIÊN HỆ KHÁM - TƯ VẤN DINH DƯỠNG**

Phòng 02A.41 - Tầng 2 Khoa khám bệnh  
Bệnh viện Quân y 103

Sáng: 6h30 - 12h00

Chiều: 13h30 - 16h30

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ)



# **KHUYẾN CÁO CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN**

# **KHUYẾN CÁO CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN**

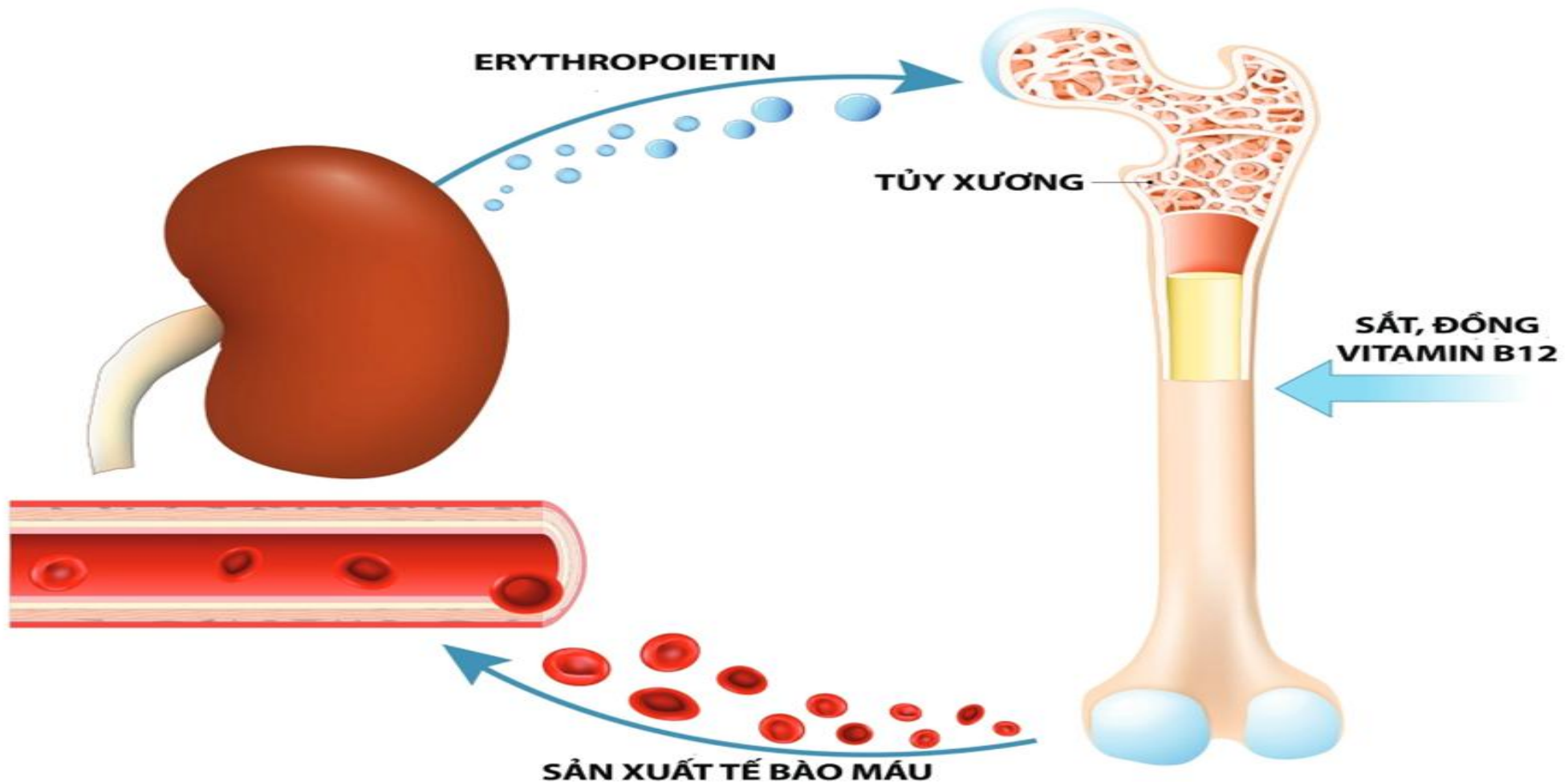
- Không nên sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn như cá khô, mì, cá hộp...
- Không ăn nhiều thực phẩm thực vật chứa nhiều đạm như giá, lạc, rau dền, rau muống...
- Không cho nhiều muối vào thức ăn khi nấu.
- Không uống các loại lá cây, rễ cây... gây quá tải cho thận.

# KHUYẾN CÁO CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN

- Sử dụng lượng nước phù hợp cho từng giai đoạn bệnh thận dựa vào tính blilan xuất nhập.
- Hạn chế ăn nhiều muối, chấm ngập nước mắm khi ăn.
- Chọn các loại thực phẩm cung cấp glucid chứa ít đạm như sắn, khoai lang, khoai tây...
- Chọn rau quả có lượng đạm thấp như dưa leo, bầu, bí, rau cải...
- Không ăn nhiều thực phẩm chứa kali, phosphat...
- Ăn vừa phải thực phẩm chứa đạm động vật và theo khuyến cáo bộ y tế...
- Tham khảo ý kiến bác sĩ.

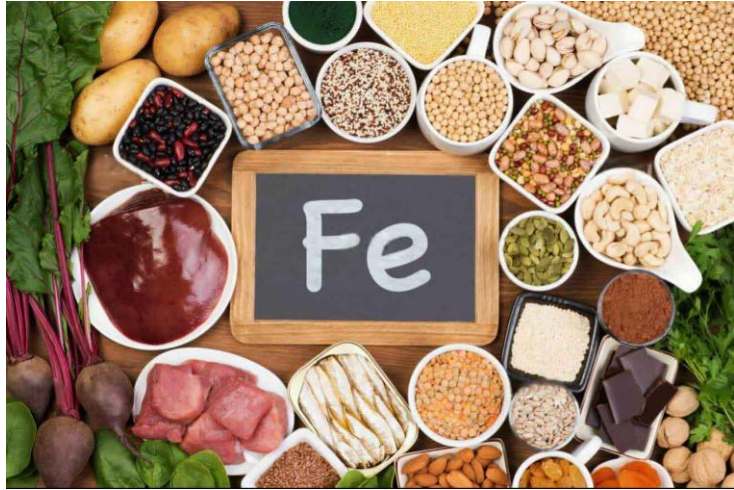


# THIẾU MÁU TRÊN BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN





# BỔ SUNG THỰC PHẨM CHO BỆNH NHÂN MẮC BỆNH THẬN MẠN





# **PHÒNG NGỪA BỆNH THẬN MẠN**



# PHÒNG NGỪA BỆNH THẬN MẠN

- Hạn chế ăn nhiều muối, hạt nêm, nước mắm...
- Không ăn quá ngọt, không uống nước ngọt...
- Không ăn nhiều dầu mỡ, nội tạng động vật...
- Khám định kỳ trên những bệnh nhân có nguy cơ như: Đái tháo đường, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu...
- ***Uống đủ nước.***



# Ngăn ngừa SUY THẬN

in|mari  
Your Partner in Service Excellence



## Kiểm soát tốt đường huyết

Hàm lượng đường trong máu cao khiến mao mạch bị tắc nghẽn, gây cản trở quá trình lưu thông của hồng cầu. Từ đó, thận sẽ không thể nhận đủ chất dinh dưỡng cũng như oxy để tiếp tục hoạt động



## Cẩn thận với chỉ số huyết áp

Ở người bệnh tăng huyết áp, bất kỳ mao mạch nào cũng có nguy cơ chịu thương tổn, bao gồm cả những mạch máu ở thận



## Giảm lượng muối hấp thụ

Hấp thụ quá nhiều muối có nguy cơ khiến nước bị tích tụ trong cơ thể, từ đó gây tăng huyết áp



## Bỏ thuốc lá

Thuốc lá cản trở lưu lượng máu đến thận, khiến tình trạng sức khỏe của cơ quan này trở nên nghiêm trọng hơn



## Hạn chế thức uống chứa cồn

Liên tục uống nhiều bia rượu trong thời gian ngắn dễ gây nên các bệnh tim mạch, yếu tố nguy cơ kéo theo tình trạng chức năng thận suy giảm



in|mari  
Your Partner in Service Excellence



# Ngăn ngừa

# SUY THẬN



Tham khảo: vinmec.com

## Tập thể dục

Giúp duy trì huyết áp ổn định, kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường và tăng huyết áp, do đó làm giảm nguy cơ mắc các bệnh về thận.



## Chế độ ăn uống lành mạnh

Tăng cường ăn rau củ quả, giảm lượng tinh bột, đường, giảm muối trong các bữa ăn hàng ngày cũng như hạn chế đồ ăn chế biến sẵn.



## Không sử dụng thuốc lá

Hút thuốc lá có thể dẫn đến xơ vữa mạch, giảm lưu lượng máu đến thận, giảm khả năng hoạt động tốt nhất của thận. Vì vậy, từ bỏ thuốc lá là cách để bảo vệ sức khỏe.



## Uống đủ nước

Uống 2 lít nước mỗi ngày sẽ giúp làm loãng nước tiểu, loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể và giúp ngăn ngừa sỏi thận.



## Kiểm tra thận định kỳ

Bệnh thận không xuất hiện triệu chứng rõ ràng cho đến khi ở giai đoạn muộn. Vì vậy, việc chẩn đoán và thực hiện biện pháp phòng ngừa từ sớm là vô cùng quan trọng.



# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1. Chất dinh dưỡng nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến bệnh nhân mắc bệnh thận mạn?**

- A. Glucid
- B. Protid
- C. Lipid
- D. Nước



# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 1. Chất dinh dưỡng nào sau đây ảnh hưởng nhiều nhất đến bệnh nhân mắc bệnh thận mạn?**

- A. Glucid
- B. Protid**
- C. Lipid
- D. Nước

# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 2. Nguyên tắc quan trọng nhất để điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn?**

- A. Chế độ dinh dưỡng hợp lý
- B. Điều trị thay thế thận
- C. Cá thể hóa
- D. Uống nhiều nước

# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 2. Nguyên tắc quan trọng nhất để điều trị bệnh nhân mắc bệnh thận mạn?**

- A. Chế độ dinh dưỡng hợp lý
- B. Điều trị thay thế thận
- C. Cá thể hóa**
- D. Uống nhiều nước



# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 3. Chế độ ăn DASH phù hợp cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn?**

- A. Giai đoạn 1 - 3
- B. Giai đoạn 2 - 4
- C. Giai đoạn 4 - 5
- D. Áp dụng cho tất cả bệnh nhân mắc bệnh thận mạn

# CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

**Câu 3. Chế độ ăn DASH phù hợp cho bệnh nhân mắc bệnh thận mạn giai đoạn?**

- A. Giai đoạn 1 - 3**
- B. Giai đoạn 2 - 4
- C. Giai đoạn 4 - 5
- D. Áp dụng cho tất cả bệnh nhân mắc bệnh thận mạn

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10 tháng 8 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn chế độ ăn bệnh viện”.
- Quyết định số 3931/QĐ-BYT ngày 21/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh về thận – tiết niệu”.
- Dinh dưỡng lâm sàng, Bộ Y tế, 2018.
- Tiếp cận chẩn đoán bệnh nội khoa, Đại học Y dược TPHCM, 2023.
- Tiếp cận điều trị bệnh nội khoa, Đại học Y dược TPHCM, 2023.
- Dinh dưỡng lâm sàng – tiết chế, Đại học Y Hà Nội, 2016.



Thank You!